

Gerente Geral

O manual da direção: o painel do dia, os números da clínica, as metas, o marketing, os acessos de cada pessoa e as configurações do sistema.

PARA QUEM É ESTE MANUAL

Direção e gerência da clínica.

Este aplicativo enxerga **tudo** — inclusive as telas da Recepção, do Consultório e do Financeiro, que têm manuais próprios.

NESTE MANUAL

Painel da direção

Indicadores e metas

Rentabilidade

Acessos e auditoria

Configurações e backup

Programa: **Clínica SemDor — Gerente Geral** (ícone azul com o nome “Gerente” na área de trabalho).

Aqui estão as telas que **só a direção** tem, e as decisões que só ela pode tomar.

O que você vai encontrar aqui

1	Antes de começar	abrir, entrar e entender a tela
2	Painel da direção	o que exige ação hoje
3	Relatórios / BI	indicadores, metas, resultado e produção
4	Metas	o alvo do mês, e por que ele muda a leitura
5	Rentabilidade e custos	quanto rende cada convênio
6	Faturamento (TISS)	a leitura gerencial das guias
7	Tabela de preço	convênios e particular
8	Marketing / Recall	campanhas, quem sumiu, de onde vêm
9	Conformidade e acessos	auditoria, guarda do prontuário, usuários
10	Acessos	quem pode o quê — a tela mais importante da direção
11	Configurações	a clínica, os prazos, backup, termos, e-mail
12	Importar pacientes	trazer a carteira do sistema antigo
13	Quando algo dá errado · FAQ · Glossário	

Antes de começar

O Gerente Geral é o único aplicativo que carrega **todos** os módulos. Por isso o menu dele é o maior — e por isso ele vem agrupado por assunto, com os grupos que abrem e fecham.

COMO LER ESTE MANUAL

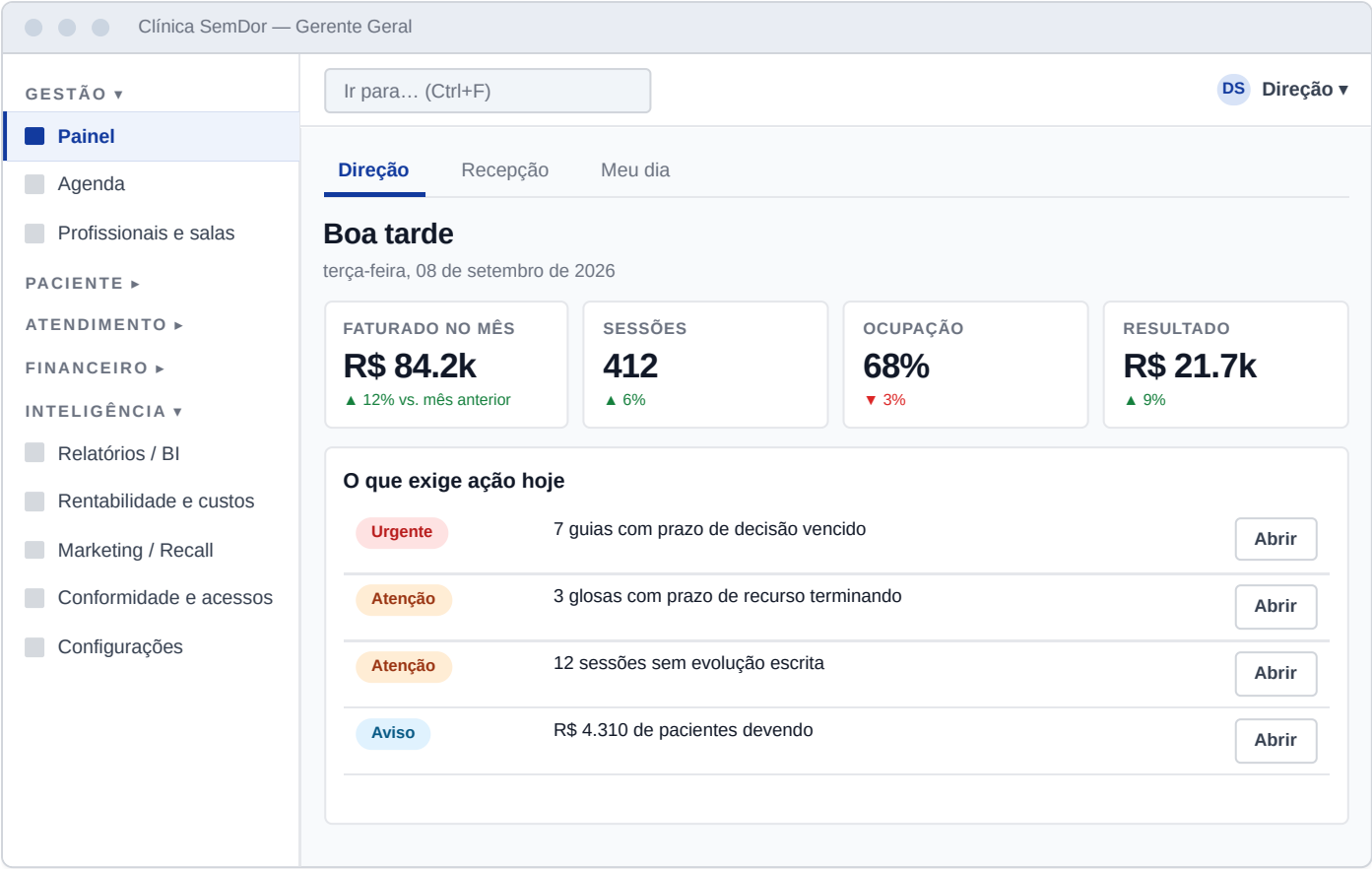
As figuras **ainda não são fotos do sistema** — são reproduções feitas a partir do próprio código, e cada uma sai marcada com um selo laranja avisando disso. Elas são fiéis no que importa: os nomes dos botões, das colunas e dos campos são **exatamente** os que você vai ver no computador, e as cores também. Assim que as capturas reais forem tiradas, elas entram no lugar e o selo some.

ESTE MANUAL NÃO REPETE OS OUTROS

As telas da Recepção (agenda, pacientes, lançamento), do Consultório (prontuário, prescrições) e do Financeiro (caixa, contas, conciliação) aparecem no seu menu e estão explicadas nos **manuals daqueles módulos**. Aqui estão só as telas que **a direção tem e os outros não**.

1.1 · A tela por dentro

ILUSTRAÇÃO — não é uma captura da tela real



O painel da direção. Cada alerta **leva** à tela onde ele se resolve — o botão fica apagado quando aquele destino não existe para o seu acesso.

1.2 · Os grupos do menu

GRUPO	O QUE TEM DENTRO
GESTÃO	O dia da clínica: painel, agenda, profissionais e salas, ajuda.
PACIENTE	A pessoa: cadastro, documentos, pacotes, preços, retorno, importação.
ATENDIMENTO	O ato de atender: lançar e marcar, prontuário, prescrições, enfermagem.
FINANCEIRO	O dinheiro: caixa, contas, recebimentos, estoque, repasses, faturamento, tabela de preço.
INTELIGÊNCIA	A leitura do negócio: BI, metas, rentabilidade, marketing, conformidade, configurações.

Clicar no nome do grupo abre e fecha aquele grupo. Navegar para uma tela abre o grupo dela e fecha os outros — assim a lista não cresce sem parar.

Ctrl + B recolhe o menu para só os ícones (e devolve); **Ctrl + F** abre a busca de telas, que também procura dentro das abas e diz o caminho (“Fechamento de caixa — em Caixa”).

Painel da direção

A tela que abre o aplicativo. Ela não calcula nada por conta própria: cada número vem do serviço que é dono dele, para não haver duas respostas para a mesma pergunta.

Menu **GESTÃO** › **Painel** › aba **Direção**

2.1 · Os blocos

BLOCO	O QUE RESPONDE
Metas do mês	Como o mês está indo contra o alvo que a direção definiu. Sem meta cadastrada, ele compara com o mês anterior — que responde “melhorou?”, nunca “chegamos onde a gente disse que ia chegar?”.
O que exige ação hoje	A lista de alertas, cada um com um botão que leva à tela onde ele se resolve.

Os alertas que aparecem

ALERTA	SIGNIFICA
Guias com prazo de decisão vencido	Guias pendentes há mais dias do que o prazo configurado. Se ninguém decidir, o faturamento trava numa janela obrigatória.
Glosas com prazo de recurso terminando	Passado o prazo, não é mais pendência — é prejuízo consumado.
Prontuário em aberto	Sessões que aconteceram e não têm evolução escrita.
Guia faturada sem prontuário	Mais grave que o anterior: é cobrança sem o documento que a sustenta.
Infusão aguardando	Folhas de infusão com item por executar.
Infusão sem assinatura	Folhas encerradas esperando a assinatura da enfermagem.
Contas a pagar / pacientes devendo	São dois alertas separados: um se resolve pagando, o outro cobrando. Somá-los daria um número sem significado.

CADA BLOCO FALHA SOZINHO

Se uma leitura não puder ser feita, aquele bloco mostra “**não foi possível verificar**” e o resto continua. Um painel dizendo “nada vencido” por causa de uma consulta quebrada seria pior do que um painel que avisa.

A COMPARAÇÃO É COM O MESMO TRECHO DO MÊS ANTERIOR

No dia 5, ele compara cinco dias com cinco dias — não cinco com trinta. Senão todo começo de mês apontaria queda de 80%, e qualquer pessoa aprenderia a ignorar a seta.

As outras duas abas do **Painel** são o painel da **Recepção** (como está o balcão agora) e o **Meu dia** do profissional — explicados nos manuais daqueles módulos.

Relatórios / BI

Cinco abas com a leitura do desempenho da clínica.

Menu **INTELIGÊNCIA** › Relatórios / BI

3.1 · Indicadores

COLUNA	O QUE MEDE
Atendidos	Sessões concluídas por profissional no período.
Faltas / No-show (%)	Quantos não vieram. Cancelamento avisado não conta como falta — quem desmarcou deu chance de reocupar.
Horas	Tempo de agenda ocupado.
Evoluções / Prontuário	Quantas sessões têm registro escrito, e o percentual. “—” quando não houve sessão — não se acusa de negligência quem tirou férias.
Queda média da dor	A diferença média entre a EVA antes e depois.
Ocupação por profissional	Medida contra os dias em que ele teve agenda × a jornada configurada — e não contra um calendário inventado.

Exportar gera a planilha. **Métrica sem base de cálculo sai como “—” também na planilha**, para o Excel não calcular média sobre um número que não existe.

3.2 · As outras abas

- **Metas** — o capítulo 4.
- **Resultado do mês** — a demonstração do período (manual do Financeiro, capítulo 15).
- **Produção** — volume de sessões e receita em 6 ou 12 meses.
- **Meus números** — a tela do profissional (manual do Consultório).

Metas

Sem meta, o painel só sabe comparar com o mês anterior — e variação responde “melhorou?”, nunca “**chegamos onde a gente disse que ia chegar?**”. Um mês 10% melhor que um mês ruim aparece como vitória.

Menu INTELIGÊNCIA › Relatórios / BI › aba Metas

- 1
- Escolha o mês (◀▶) e clique em **Nova meta**.
- 2
- Indicador** (faturamento, sessões, ocupação...), **de quem** (a clínica ou um profissional) e o **alvo**.
- 3
- Salve. A tela passa a mostrar **Realizado** e **Situação** ao lado do alvo.

REGRA	POR QUÊ
Uma meta por mês, por indicador, por pessoa	Duas metas para a mesma pergunta dariam duas réguas, e a tela escolheria uma sem dizer qual.
Sem meta ≠ meta zero	Sem linha é “não decidimos”; zero é “decidimos que é zero”. Inventar zero faria todo mês não planejado aparecer como alvo batido.
Reajustar agosto não reescreve julho	Cada mês é uma linha própria.
Não se projeta mês com menos de 5 dias	Projetar no dia 2 multiplica ruído por quinze.
Ocupação não se projeta por regra de três	Ela já é uma média; multiplicá-la pelos dias que faltam daria 300%.

VER O NÚMERO E DECIDIR SOBRE ELE SÃO ACESSOS DIFERENTES

Dar acesso ao BI não dá o poder de apagar as metas do ano. São dois bits separados, e a direção pode conceder um sem o outro.

Rentabilidade e custos

Menu INTELIGÊNCIA › Rentabilidade e custos

5.1 · Por convênio

A leitura que decide negociação de tabela.

COLUNA	O QUE É
Guias	Quantas guias daquela operadora no período.
Bruto	O valor cheio.
Retido	O imposto que a operadora reteve na fonte.
Líquido	O que sobrou.
Por guia	A leitura central. É o único número comparável entre operadoras com valores e volumes diferentes — a “menos rentável” é apurada por guia, e não pelo total, que apontaria sempre a de menor volume.
Prazo	O tempo médio até o pagamento. Só conta o que já foi pago — incluir o previsto mediria uma promessa, e quem atrasa teria o melhor número.

O AGRUPAMENTO É POR OPERADORA, NÃO POR FAMÍLIA DE REGRA

Duas operadoras podem compartilhar a mesma regra de faturamento e mesmo assim ser negócios diferentes. Somá-las daria “Porto Saúde: 143 guias” quando são duas operadoras juntas — o número que a direção usa para negociar.

5.2 · Custo de taxas e impostos

Quanto a clínica paga de maquininha e de imposto, mês a mês. A leitura que só existe aqui é a **taxa efetiva contra a de tabela**: a tabela diz 3,1%, e se a clínica parcela mais do que imagina o efetivo é 3,9%. É essa diferença que dá argumento na renegociação.

A tabela vem como **faixa** (menor e maior taxa vigente), porque uma adquirente tem várias taxas e um número só teria de escolher uma modalidade.

Faturamento (TISS)

A leitura **gerencial** do faturamento, em cinco abas. Quem opera as guias no dia a dia é o aplicativo de Faturamento (manual próprio); aqui a direção acompanha e, quando precisa, age.

Menu **FINANCEIRO** › **Faturamento (TISS)**

ABA	O QUE MOSTRA
Visão geral	Por convênio: guias geradas, baixadas, pendentes, taxa de baixa , glosa e tempo médio. Mais a evolução da taxa de baixa e as pendências por faixa de atraso.
Pendências	As guias esperando baixa, com filtros por convênio, urgência e paciente. Dá para Dar baixa e Anotar aqui mesmo.
Glosas	As guias recusadas, com prazo de recurso. Reapresentar registra o recurso; Recuperada registra que o convênio pagou.
Não conformidades	As guias que alguém decidiu não faturar , com a justificativa escrita. Reabrir devolve a guia à fila de pendências.
Lotes	Os lotes TISS gerados, enviados e com retorno. Aqui é só leitura : gerar lote é do aplicativo de Faturamento, porque o número do lote é uma sequência e dois programas gerando ao mesmo tempo produziriam lotes duplicados que a operadora recusa.

Fechamento em PDF gera o relatório do período para arquivar ou mandar ao contador.

DAR BAIXA DAQUI É O MESMO ATO DO FATURAMENTO

Inclusive a conferência do **número da guia**: cada convênio tem um formato (a Unimed só numera com dígitos, por exemplo), e o sistema critica enquanto você digita — para o “O” no lugar do zero não passar e só aparecer no retorno da operadora, semanas depois.

Tabela de preço

Menu **FINANCEIRO** › Tabela de preço

7.1 · Convênios

Quanto cada convênio paga por cada tipo de guia. É o que faz a **Conciliação** do Financeiro abrir já com o valor preenchido e a procedência escrita ao lado.

- 1 **Novo preço.**
 - 2 Escolha o **convênio**, o tipo de guia e, se o preço muda por especialidade, a **especialidade**.
 - 3 Informe o **valor** e a **vigência**.
 - 4 Salve.
- A regra **mais específica ganha** — especialidade vence o genérico.
 - Reajuste é **linha nova**: a guia de março segue valendo o preço de março.
 - **Sem preço cadastrado o campo fica vazio**, e não zero — chutar um valor de mercado daria receita errada com aparência de exata.
 - **Só o que vale hoje** esconde as linhas fora de vigência.

7.2 · Particular

A mesma ideia para quem não tem convênio, chaveada pelo que a clínica **faz**: **modalidade** (obrigatória) + **especialidade atendida** (opcional). Está explicada no manual da Recepção, capítulo 10 — a direção e o balcão cadastram na mesma tela.

Marketing / Recall

Menu **INTELIGÊNCIA** › **Marketing / Recall**

8.1 · Campanhas

Três tipos de contato, todos com o mesmo registro:

RODADA	O QUE FAZ
Confirmações de amanhã	Monta a lista de quem tem horário amanhã, para confirmar. Não exige autorização de marketing — confirmar a própria sessão é assunto do atendimento.
NPS de ontem	Pergunta a nota a quem foi atendido ontem. Exige autorização.
Recall do mês	Convida de volta quem não vem há um tempo. Exige autorização.

- 1 Clique no botão da rodada que quer gerar.
- 2 A lista aparece com **paciente, telefone, campanha e situação**.
- 3 **WhatsApp** abre a conversa com a mensagem pronta — um clique por pessoa, porque o número é o WhatsApp da clínica.
- 4 **Respondeu / Nota** registram o retorno; **Dispensar** tira o contato da fila.

QUEM NÃO AUTORIZOU APARECE CONTADO, COM O MOTIVO

Em vez de sumir da lista. Some da lista, some da cabeça — e “12 pacientes” que eram 30 faz a clínica concluir que quase ninguém está sumindo. **Dispensar** é a permissão que faz um contato sumir da fila **sem ninguém ter falado com o paciente**, e por isso ela é da direção.

8.2 · Quem parou de vir

A lista caso a caso, para a direção decidir quem vale um telefonema de verdade — o paciente de tratamento longo que some vale dez recalls disparados no vazio.

- **Quem tem sessão futura marcada não aparece**, por mais tempo que faça desde a última: ele já voltou, só ainda não veio.
- **Só quem era frequente** e **Só com pacote em aberto** estreitam a lista. O segundo é o caso que a clínica deve tanto ao paciente quanto a si: ele pagou sessões que não usou.
- **Chamar de volta** abre o WhatsApp; **Exportar CSV** gera a planilha.

8.3 · De onde vêm os pacientes

Responde a pergunta que justifica a pergunta do balcão (“como conheceu a clínica?”):

- **Origem × na base × % da base × estrearam no período.**
- **Quem mais indica (10 maiores)** — as pessoas que trazem pacientes.
- **“Estreou no período”** = o **primeiro atendimento** daquela pessoa caiu no período. Cadastro sem atendimento é intenção; atendimento é a clínica trabalhando.
- **“Não perguntado”** aparece como linha normal, ordenada junto das outras. Quando ela encabeça a tabela, o achado do relatório é que o balcão parou de perguntar.

8.4 · Retorno de pacientes

A tela de telefonar, que a Recepção também tem — está no manual dela, capítulo 11.

Conformidade e acessos

Três abas que respondem às perguntas de uma auditoria: **quem fez**, **quem leu** e **o que a clínica guarda**.

Menu **INTELIGÊNCIA** › **Conformidade e acessos**

9.1 · Auditoria

A trilha de tudo o que foi feito no sistema: quem, quando e o quê.

- 1 Escolha o período em **De** e **Até** (o dia final entra inteiro).
- 2 Filtre por **ação** (basta o começo: “Conta” acha ContaCriada e ContaReagendada), **operador**, **paciente** ou um trecho **no detalhe**.
- 3 Marque **Só quem ABRIU o prontuário** para investigar acesso indevido de **leitura** — que é o caso clássico numa clínica, e o que a permissão sozinha não cobre.
- 4 **Consultar**. **Exportar** gera a planilha.

A TRILHA É SOMENTE LEITURA

Não há como editar nem apagar um registro de auditoria — nem aqui, nem em lugar nenhum. Registro de auditoria que se pode alterar não é auditoria, é rascunho.

QUANDO ELE AVISA QUE BATEU NO LIMITE

A consulta tem um teto de linhas. Se ele for atingido, a tela **diz** — “300 eventos” que na verdade são 300 de 4.000 faria a direção concluir que o período teve pouca movimentação.

9.2 · Guarda do prontuário

A tela que responde ao auditor “**o que vocês guardam, e por quanto tempo**”.

BLOCO	O QUE MOSTRA
A clínica inteira	Prazo legal, quantos pacientes, quantos têm prontuário, quantos registros guardados, quantos já cumpriram o prazo e qual é o registro mais antigo.
Um paciente	Escolha a pessoa e clique em Calcular a guarda : até quando aquele prontuário precisa ser guardado.

BLOCO	O QUE MOSTRA
Quem abriu este prontuário	A trilha de leitura daquele paciente — quem abriu, quando e por qual porta.
Exportar o prontuário	De uma pessoa, ou da clínica inteira.

O PRAZO CONTA DO ÚLTIMO REGISTRO, E O SISTEMA NÃO ELIMINA NADA

São **20 anos** a partir do último registro de qualquer natureza, e o prazo é legal — não é configurável, justamente para ninguém baixá-lo sem perceber. Vencido o prazo, o prontuário fica **elegível**; a decisão de eliminar é da clínica, com a comissão prevista em lei. Eliminar sozinho seria ler um **piso** de guarda como agendamento de destruição.

9.3 · Acessos

É o [capítulo 10](#) — a tela mais importante da direção.

Acessos — quem pode o quê

Cada pessoa entra com o próprio usuário, e o que ela alcança é decidido aqui. **Item que a pessoa não pode usar simplesmente não aparece no menu dela.**

Menu **INTELIGÊNCIA** › **Conformidade e acessos** › aba **Acessos**

10.1 · Criar um usuário

- 1 Novo usuário.
- 2 Nome, login (sem espaços) e uma **senha provisória**.
- 3 **Perfil**: Recepção, Profissional, Enfermagem, Financeiro, Faturista ou Gerente. O perfil é só o **ponto de partida** das permissões.
- 4 **Profissional**: se a pessoa atende, ligue o usuário ao cadastro dela. **É essa ligação** que faz a agenda ser a dela, o conselho (CRM/COREN) ser copiado nos registros e o CPF do certificado digital ser conferido na assinatura.
- 5 Salve. Na primeira entrada, o sistema pede que ela troque a senha.

10.2 · Ajustar permissões

Dentro do usuário, as permissões vêm **agrupadas por assunto**, com a **consequência escrita ao lado de cada caixinha** e a **procedência** de cada uma: padrão da função, liberada à mão ou tirada à mão.

- **Marcar** uma caixinha libera aquela função só para aquela pessoa.
- **Desmarcar** tira. O que foi tirado à mão **vence** o padrão do perfil.
- Corrigir o **padrão de um perfil** alcança quem já está cadastrado — o cálculo é *padrão + liberadas – tiradas*, feito toda vez que a pessoa entra.

10.3 · Os cortes que valem a pena entender

SEPARAÇÃO	POR QUÊ
Ficha × Prontuário	Ver ficha é contato (telefone, convênio). Ver prontuário é dado de saúde. É o corte da LGPD, e é o que impede a recepção de ler a evolução de todo mundo para marcar um horário.
Baixar × Estornar	Errar a baixa é acidente; estornar apaga o trabalho de outra pessoa. Por isso o faturista baixa e não estorna.

SEPARAÇÃO	POR QUÊ
Marcar agenda × Mover a fila	O profissional move a fila (chegada, chamada, entrada) sem ganhar a agenda do balcão.
Ver indicadores × Definir metas	O realizado é fato; a meta é a decisão da direção sobre o fato.
Não conformidade	É a única permissão que faz uma pendência sumir do painel sem a guia ter sido faturada — quem a tem pode zerar o alarme sobre o próprio trabalho que ele cobra.

TROCAR DE USUÁRIO REABRE O APLICATIVO

É de propósito: as telas leem a permissão quando são construídas, e metade delas já está aberta. Permissão que **parece** aplicada e não está é pior do que permissão nenhuma.

REDEFINIR SENHA

Gera uma provisória, que a pessoa troca ao entrar. A direção **não vê** a senha de ninguém — e entregar a senha nova pronta trocava um segredo comprometido por um que já nasce compartilhado.

O SISTEMA NÃO DEIXA A CLÍNICA FICAR SEM NINGUÉM QUE GERENCIE ACESSOS

Ele recusa excluir ou rebaixar o último usuário com essa permissão. E se a base ainda não tiver usuário nenhum, o primeiro acesso cria um Gerente — em vez de trancar todo mundo do lado de fora.

Configurações

Sete blocos. Cada um tem o seu próprio botão de **Salvar** — salvar um não mexe nos outros.

Menu **INTELIGÊNCIA** › **Configurações**

11.1 · A clínica

Razão social, nome fantasia, CNPJ, CNES, endereço, telefone, e-mail, cidade e **chave Pix**. É o que sai impresso no cabeçalho de todas as folhas que a clínica entrega.

11.2 · Operação e marketing

CAMPO	O QUE MUDA
Jornada diária (minutos)	A base da ocupação . Sem ela, a ocupação seria calculada contra dias úteis inventados.
Recall: dias sem vir	A partir de quantos dias o paciente entra na lista de recall.
Faturamento na marcação	Liga a opção de a guia nascer já quando o horário é marcado , e não só quando o atendimento é lançado. Veja o aviso abaixo.
Escrever termos...	Cadastra os termos que o paciente assina (consentimento, jejum) e diz qual procedimento exige cada um. Há um botão que cria os termos do BSV prontos.
Campos do prontuário...	Cria campos próprios da clínica na folha da sessão (“nº de agulhas”, “aparelho”). Cada campo diz em que modalidade aparece.

ANTES DE LIGAR “A GUIA NASCE NA MARCAÇÃO”

Atualize os cinco aplicativos primeiro. Um programa desatualizado não entende os registros que o novo cria, e a tela dele pode parar de abrir. A própria tela avisa isso ao lado da caixinha.

11.3 · Regras de faturamento (os prazos)

PRAZO	O QUE ELE CONTROLA
Alerta de consulta (dias)	Com quantos dias de antecedência o sistema avisa que a consulta do convênio vai vencer.

PRAZO	O QUE ELE CONTROLA
Recurso de glosa (dias)	O prazo para recorrer de uma glosa. É ele que o painel vigia.
Prazo de decisão (dias)	Quantos dias uma guia pode ficar pendente antes de o sistema travar o faturamento numa janela obrigatória. Padrão: 10.
Consultas a renovar / Carteirinhas a vencer	Duas caixinhas que estendem a rodada obrigatória a esses dois assuntos.

11.4 · Backup da clínica

- 1 **Escolher pasta...** — onde as cópias serão guardadas.
- 2 **Copiar a cada (dias) e Cópias a guardar** — a rotação. Guardar só a última é o erro clássico: a corrupção que ninguém viu na sexta é copiada por cima da única cópia boa no sábado.
- 3 **Salvar política.** A partir daí a cópia acontece na **abertura do Gerente**, quando o prazo vence.
- 4 **Copiar agora** força uma cópia; **Conferir um backup** verifica um arquivo já gravado.

GUARDE A CÓPIA FORA DA MÁQUINA

O sistema não tem como saber se a pasta escolhida está num pen drive, num HD externo ou na nuvem — e por isso ele **não promete** que o backup está seguro. Escolha uma pasta que seja sincronizada para fora do computador, e confira de vez em quando.

11.5 · Lembretes por e-mail

Servidor SMTP, porta, usuário, senha, remetente e nome do remetente. Com isso configurado, o sistema manda o lembrete da sessão por e-mail na abertura do dia — e quem já foi avisado pelo WhatsApp **não** recebe e-mail. **Enviar arquivo de teste** confere se está funcionando antes de valer para os pacientes.

Sem servidor configurado, **nada muda**: o balcão continua confirmando por WhatsApp, um clique por pessoa, exatamente como antes.

11.6 · Publicação de documentos assinados

Onde ficam hospedados os documentos assinados que o paciente leva com QR code (para a farmácia conferir). Campos: domínio da clínica, dias no ar e os dados do armazenamento. **Enviar arquivo de teste** grava um PDF de exemplo e devolve o endereço para você abrir no navegador — é o teste que prova que o farmacêutico vai conseguir abrir.

11.7 · Tela do paciente

Escolhe qual **monitor** é o do paciente, quando a clínica tem um monitor com toque para colher assinatura. Há um botão **Testar**: as telas se chamam “DISPLAY1” e “DISPLAY2” e ninguém sabe qual é qual pelo nome — sem testar, o primeiro a descobrir que abriu no monitor errado seria o paciente.

Importar pacientes

Traz a carteira de pacientes (e o prontuário) do sistema antigo. Funciona em **dois tempos**: primeiro ele mostra o que **vai** acontecer, sem gravar nada; depois você manda gravar.

Menu **PACIENTE** › Importar pacientes

- 1 • O arquivo.** Escolha o pacote (ZIP) do sistema antigo, ou um CSV de pacientes, ou o ZIP de arquivos (receitas, laudos).
- 2 • O que cada coluna significa.** O sistema **sugere** a correspondência entre as colunas do arquivo e os campos daqui. **Confira uma por uma** — nomes de coluna enganam (“operadora” pode ser a do celular, não o convênio).
- Aponte cada **convênio do arquivo** para um convênio cadastrado aqui. O que você não apontar entra como **“A definir”**, e o sistema vai perguntar no balcão quando aquele paciente aparecer.
- Gerar a prévia.**
- 3 • O que vai acontecer.** Linha por linha: qual ficha será **criada**, qual será **completada** e qual será **ignorada** — com o motivo.
- Só então mande executar.

IMPORTAR DUAS VEZES NÃO DUPLICA

Cada ficha guarda a chave do sistema de origem. Quem já existe é **completado**, nunca sobrescrito: o convênio que a clínica já ajustou aqui permanece. E duplicatas **dentro do próprio arquivo** entram fundidas numa ficha só.

A ORDEM IMPORTA PARA O ZIP DE ARQUIVOS

Importe primeiro o pacote de **pacientes**, depois o ZIP de **arquivos** — os arquivos são ligados às fichas pelo id do sistema antigo. Quando o arquivo só traz o nome, ele é ligado apenas se o nome for **único**; homônimos ficam de fora **com o motivo escrito**, em vez de irem para a ficha errada.

“FECHOU” NÃO QUER DIZER “TUDO ENTROU”

Quer dizer que **o que não entrou está listado, com a razão**. Leia a lista do que ficou de fora antes de dar a importação por concluída.

Quando algo dá errado · FAQ · Glossário

13.1 · Quando algo dá errado

O QUE APARECE	O QUE FAZER
“Não foi possível verificar” num bloco do painel	Aquela leitura falhou. Não é “nada pendente” . Use Atualizar ; se insistir, é problema de conexão ou defeito.
Uma pessoa diz que “sumiu um menu”	É permissão. Abra Acessos , o usuário dela, e confira a caixinha correspondente.
A agenda de um profissional aparece vazia no app dele	O usuário dele não está ligado ao cadastro de profissional. Corrija em Acessos .
Um número não bate com outra tela	Confira se as duas usam o mesmo período e o mesmo recorte. Cada número vem do serviço dono dele — as telas não recalculam por conta própria.
Um erro em inglês	Falha técnica. Anote a hora e o que estava sendo feito. O detalhe fica em <i>erros-ano-mês.txt</i> , na pasta “logs” ao lado do programa — é o que o suporte vai pedir.

13.2 · Perguntas frequentes

Como libero uma função só para uma pessoa?

Acessos › o usuário › marque a caixinha. Não é preciso mudar o perfil dela nem mexer no das colegas.

A recepcionista precisa digitar a evolução que o profissional dita.

Conceda **Escrever no prontuário** àquela pessoa, em **Acessos**. Foi exatamente para isso que a permissão é granular.

Como sei quem abriu o prontuário de um paciente?

Conformidade e acessos › **Guarda do prontuário**, escolha o paciente e veja “**Quem abriu este prontuário**”. Ou **Auditoria** com a marca “**Só quem ABRIU o prontuário**”.

Um paciente pediu para excluir os dados dele.

Prontuário não se apaga (a lei manda guardar 20 anos). O caminho é a **anonimização**, na ficha do paciente, aba LGPD: nome, documento, telefone e foto saem; o histórico fica sem dono identificável. A tela avisa isso antes de fazer.

Quero mudar o prazo em que uma guia vira “urgente”.

Configurações › Regras de faturamento › Prazo de decisão (dias).

Onde vejo se o backup está sendo feito?

Configurações › Backup da clínica. Ele roda na abertura deste aplicativo, quando o prazo vence. Se ninguém abrir o Gerente, o backup não acontece.

Posso gerar o lote TISS aqui?

Não — só no aplicativo de Faturamento. O número do lote é uma sequência, e dois programas gerando ao mesmo tempo produziram lotes duplicados que a operadora recusa semanas depois.

13.3 · Glossário

Indicador	Um número que mede a clínica (sessões, ocupação, faltas, margem).
Meta	O alvo definido pela direção para um indicador, num mês.
Teto de gasto	O limite de despesa de uma categoria no mês.
Ocupação	Quanto da agenda foi usado, contra os dias em que o profissional teve agenda × a jornada configurada.
No-show	Faltas sem aviso, em percentual.
Rentabilidade por guia	Quanto sobra por guia de cada convênio — o número comparável entre operadoras.
Taxa de baixa	Quantas das guias geradas foram efetivadas no convênio.
Glosa	Recusa de pagamento pelo convênio, com prazo para recurso.
NC (não conformidade)	A decisão registrada de não faturar uma guia, com justificativa.
Lote TISS	O pacote de guias enviado ao convênio no padrão da ANS.
Recall	Chamar de volta quem parou de vir. Exige autorização de contato.
NPS	A nota que o paciente dá à clínica depois do atendimento.

Auditoria	A trilha do que foi feito no sistema: quem, quando e o quê. Somente leitura.
Guarda	O prazo legal de 20 anos em que o prontuário precisa ser conservado.
Anonimização	Apagar a identificação do paciente mantendo o histórico. É o que a LGPD permite quando o prontuário não pode ser destruído.
Perfil	O ponto de partida das permissões de um cargo. As permissões individuais vencem o perfil.

Este manual descreve as telas exclusivas do Gerente Geral. As telas que ele compartilha com os outros aplicativos estão nos manuais da **Recepção**, do **Consultório**, do **Financeiro** e do **Faturamento**.